

■ 脳卒中／肺炎予防

アジア太平洋の脳卒中関連肺炎 日本2.6%～タイ15.8% 診断基準で差

ナラティブレビュー 発症72時間以内が多く、口腔ケアRCTは1件

急性期脳卒中の合併症である脳卒中関連肺炎(SAP)を、アジア太平洋地域でまとめたナラティブレビューです。有病率は日本2.6%、シンガポール5.5%、中国の全国登録10.4%、タイ15.8%と幅があり、著者は診断基準・重症度・ケアの場の違いが差を生むとしています。(系統的な統合ではありません)

日本のコホートでは、SAPの77.3%が発症後72時間以内でした。危険因子は脳卒中の重症度が最も一貫し、嚥下障害・人工呼吸・高齢が続きます。予防的な抗菌薬の大規模試験では改善せず、中国の評価者盲検RCTでは、個別化した口腔ケアでSAPが10.26%、対照は32.43%でした。危険因子の検討では、これらを組

み合わせた層別化の道具の評価が今後の課題とされています。

口腔ケアの結果は1件の試験で、SAPの定義も研究ごとに違い、数字は直接比べられません。回復期でも、嚥下と口腔の評価・ケアを多職種で続ける意味を考える材料になります。



早期の嚥下・口腔の評価とケアを、多職種で続ける

出典 **Cerebrovasc Dis** ↗

数字で見る

2.6～15.8%

国・登録による有病率の幅

77.3%

日本のコホートで72時間以内に発症

10.26%

口腔ケア群のSAP（対照32.43%）

■ 心大血管／遠隔リハ

急性冠症候群後の遠隔心臓リハ センター型と同等 129人RCT

スペインの単一病院で129人（遠隔65人・センター64人、平均57.6歳、男性86.8%）を割り付けました。8週時点で7つの目標のうち4つ以上を達成した割合は遠隔86.0%、センター79.7%（P=0.37）で、運動耐容能の群間差ありません（P=0.67）。

単一施設・男性中心で、生活習慣は自己申告です。非劣性のために設



計された試験で、Medscapeの報道ベースの要約のため原著の確認が必要です。

出典 **Eur Heart J Open** (Medscape報道) ↗

■ 制度／介護報酬

2027年度介護報酬改定、基本報酬 大幅引き上げ求める声多数

報道によると、「これまでにない基本報酬の大幅な引き上げ」を求める意見が多数でした。物価・賃金の上昇と人材確保が理由です。健保連の委員は、保険料や利用者負担の増加への配慮を求めました。基本的な視点には、処遇改善、地域包括ケアの深化、制度の持続可能性が挙げられました。

いずれも委員の意見で、改定の結論ではありません。



ません。リハの加算や通所・施設の評価は今後の議論次第で、現時点では見通せません。審議の資料と報道を追っておきたい局面です。

出典 **ミクスGemMed** ↗

短信

〈嚥下〉がんの術前嚥下造影と術後嚥下障害

中咽頭がんの経口手術後89人。術前の軽度の嚥下障害は術後の中等度以上の嚥下障害と関連(調整OR 4.69)。

出典 **Oral Oncol** ↗

〈フレイル〉地域運動教室とフレイル

アイルランドの教室1,290人。フレイル群も24週で歩行速度とTUGが改善。脱落は多い。 出典 **J Frailty Aging** ↗

〈利用実態〉脳卒中のPT利用率は17.0%

ブラジルの調査88,531人。脳卒中でPT利用が最高の17.0%。専門職の継続診察が共通の関連因子。

出典 **Braz J Phys Ther** ↗

〈関節リウマチ〉PTは「最後の手段」になりがち

米国の質的研究。患者24人・医師6人・PT6人の面接。薬物療法優先で、PTの話題が遅れる課題が出た。

出典 **Arthritis Care Res** ↗

〈小児嚥下〉白質ジストロフィー児の嚥下

小児22人の後ろ向き解析。72.7%に嚥下障害、誤嚥性肺炎の既往が22.7%。口腔期の障害が中心。

出典 **Eur J Paediatr Neurol** ↗

〈脊髄損傷〉頸髄損傷の定量評価レビュー

ナラティブレビュー（73報）。単独の評価は不十分で、臨床評価とウェアラブル・AIの併用を提案。

出典 **J Spinal Cord Med** ↗

〈栄養〉鼻咽頭がんのサルコペニア予防

多職種でケア経路を作成。医療者21人の面接を踏まえ、栄養・運動など5領域を整理。有効性は未検証。

出典 **Support Care Cancer** ↗

〈教育〉熟練PTの誘導は時間要素に差

PT各10人の運動再現課題。熟練者は移動時間やピーク速度のタイミング誤差が小さかった。小規模。

出典 **J Phys Ther Sci** ↗